

სოციალური უზრუნველყოფის სისტემის სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები

შოთა გურული
სტუ-ს დოქტორანტი

რეზიუმე

სტატიაში „სოციალური უზრუნველყოფის სისტემის სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები“ აღნიშნულია, რომ სისტემამ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე დიდი და რთული გზა განვლო, სანამ დღევანდელი სახეს მიიღებდა. 1991-2003 წლამდე ქვეყანაში ეკონომიკური გამოცოცხლების პერიოდი იყო, როცა ვერ მოხერხდა სწრაფი და სტაბილური ეკონომიკური ზრდის მიღწევა. 2004 წლის შემდგომი პერიოდში გატარდა რადიკალური ლიბერალური რეფორმები.

განსაზღვრულია, რომ თავისუფალ ბაზარზე ორიენტირებული რეფორმების პირველმა ეტაპმა ქვეყანას სწრაფი ცვლილებების გატარების შესაძლებლობა მისცა. სტაბილური სოციალური მდგომარეობის და დამოუკიდებლობის შესანარჩუნებლად, სასიცოცხლოდ აუცილებელია ეკონომიკური განვითარების მაღალი ტემპის ხანგრძლივად შენარჩუნება.

დადგენილია, რომ მოსახლეობის სოციალური დაცვა ნებისმიერი სახელმწიფოს სოციალური პოლიტიკის მთავარ ამოცანას წარმოადგენს. ბოლო ათწლეულების ეკონომიკური, თუ დემოგრაფიული ტენდენციებიდან გამომდინარე აუცილებელია სახელმწიფოს მხრიდან დროულად მოხდეს საჭირო სოციალური რეფორმების გატარება, რომლებიც ადეკვატურად უპასუხებენ არსებულ სიტუაციას.

საკვანძო სიტყვები: სოციალური უზრუნველყოფა, საყოველთაო დაზღვევა, საპენსიო რეფორმა, სახელმწიფო ბიუჯეტი.

MAIN DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF SOCIAL SECURITY SYSTEM

Shota Guruli
PhD student of GTU

SUMMARY

In the article “The main directions of the improvement of social security system” indicate that the system has gone through a long and difficult road until today’s form. From the time of independence of Georgia, it has gone through a difficult path that covers several stages. It is noted that before 2003 the economic recovery period in the country was not able to achieve rapid and stable economic growth. As well as the post-2004 period when radical liberal reforms were undertaken.

It is noteworthy that the first stage of free market-oriented reforms allowed the country to make corrective changes. To maintain a stable social situation

and independence, it is vitally necessary to maintain a high rate of economic development.

It is established that social protection of the population is the main task of social policy of any state. Depending on the economic and demographic trends of the last decade, it is necessary to take the necessary social reforms in a timely manner that will adequately respond to the current situation.

Keywords: Social security, universal insurance, pension reform, state budget.

შესავალი

ბოლო წლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტების სათავეში ექცევა ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, რომლის მთავარი მიზანიც ადამიანზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის, საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ამოქმედებაა.

ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვაზე საუბრისას აუცილებლად უნდა ვახსენოთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რომელიც 2013 წელს ამოქმედდა და მას სოციალური მომსახურების სააგენტო ახორციელებს. პროგრამის მიზანი იყო საქართველოს ყველა იმ მოქალაქის ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა, რომელიც 2013 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით არ სარგებლობდა უკვე არსებული სახელმწიფო დაზღვევით და არ გააჩნდა კერძო დაზღვევა. მისი წვლილი დიდია მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებით საქართველოს მოსახლეობას გაუჩნდა მნიშვნელოვანი სოციალური გარანტიები. თუმცა, პროგრამის მასშტაბებმა გააჩინა რისკები. მთავრობაში აქტიურად დაიწყო მუშაობა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ეგრეთ წოდებული „მეორე ტალღის“ რეფორმაზე.

სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებით, საპენსიო პოლიტიკის შემუშავება მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში მიმდინარე დებატების ფუნდამენტურ კომპონენტს წარმოადგენს. არაერთი განვითარებული თუ განვითარებადი ქვეყანა ჯერ კიდევ საპენსიო სისტემების მოდიფიცირების პროცესშია, რომლის მიზანია ადეკვატური საპენსიო შემოსავლის უზრუნველყოფა, საპენსიო ხარჯების ფისკალური მდგრადობა და მოსახლეობის დემოგრაფიული ცვლილებების მიმართ უფრო ეფექტიანი რეაგირება.

დასახული მიზნების მისაღწევად, კი ეკონომიკური განვითარებისათვის საჭირო რეფორმების გატარების აუცილებლობაც დგას, მათ შორის: საპენ-

სიო რეფორმა; კაპიტალის ბაზრის რეფორმა; საჯარო-კერძო პარტნიორობის სისტემის განვითარება.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში, შეიქმნა საპენსიო რეფორმის სამსახური, რომელმაც შეიმუშავა საპენსიო რეფორმის სტრატეგია რაც ითვალისწინებს სოციალური პენსიის ზრდის მექანიზმის შემუშავებას (ინდექსაციას) და დამატებითი საპენსიო სისტემის კომპონენტის - კერძო დაგროვებითი საპენსიო მოდელის დანერგვას. სტატიის მიზანია არსებული მდგომარეობის განხილვა.

ძირითადი ნაწილი

საქართველოში სოციალური დაცვის პოლიტიკა დაფუძნებულია მისამართულ დახმარებაზე. სადაც სოციალური პოლიტიკის მთავარ პრინციპად რჩება სახელმწიფოს მიერ რესურსების მიწოდება შეფასების სისტემის მიერ გამოვლენილი ყველაზე გაჭირვებული ადამიანებისათვის. ამავდროულად, სახელმწიფოს მთავარი ამოცანაა გააუმჯობესოს მისამართულობა და ამისათვის გამოიყენოს მრავალფეროვანი საშუალებები. ფულადი დახმარება და სამედიცინო დაზღვევის სქემის განვითარება. ესენია მთავარი საფუძველი, რომელსაც სოციალური ინტეგრაცია, სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვა ეყრდნობა.

ბოლო ათწლეულის ეკონომიკურმა ზრდამ დადებითი გავლენა მოახდინა და მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა სიღარიბის რისკის შემცირებაში. 2005 წლის შემდეგ საქართველოში სიღარიბის დონე შემცირდა, ამის პარალელურად შემცირდა სიღარიბის სიღრმე და სიმწვავე. ამის მიზეზი იყო ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლების გაუმჯობესება. ასევე მოხდა მიზნობრივი სახელმწიფო დახმარებების დანიშვნა. გაიზარდა სახელმწიფო პენსია და ხელფასები.

სახელმწიფო პენსიის ზრდამ და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შემოღებამ, ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტის მოცულობის ზრდა განაპირობა და საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის თითქმის მესამედს გაუტოლდა. ის ყოველ წელს იზრდება, რასაც სისტემაში არსებული დანახარჯების ზრდა განაპირობებს. 2018 წლის ბიუჯეტის პირველადი პროექტის მიხედვით, ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი 3.5 მილიარდი ლარი იქნება, რაც 2017 წლის მაჩვენებელს 112 მილიონით აღემატება. სამინისტროს ბიუჯეტის ზრდა საყოველთაო ჯანდაცვის ბიუჯეტის ზრდას უკავშირება, რაც 2017 წლის მაჩვენებელს 44 მილიონი ლარით აღემატება. ასევე 1.7 მილიარდ ლარამდე იზრდება საპენსიო ფონდი, რაც 2017 წლის მაჩვენებელს 20 მილიონით აღემატება.

ჯანდაცვის სექტორი ის სფეროა, სადაც საქართველოს ხელისუფლებას ყველაზე მეტი მიღწევები გააჩნია - უნივერსალური სახელმწიფო დაზღვევის და ჩვეულებრივი პროგრამებმა უამრავი ადამიანის გადარჩენა შეძლო და საზოგადოების თუ ექსპერტების მხრიდან, ძირითადად, მოწონებით სარგებლობს.

თუმცა, უნდა ითქვას, რომ ნებისმიერი რეფორმა იდეალური არასდროს არის. დროთა განმავლობაში კურსის და პროგრამების კორექტირება ყოველთვის დაუსრულებელი პროცესია. ამ ყველაფრის დასტურია, სამინისტროს ბიუჯეტის ზრდა. როგორც უკვე აღვნიშნე ამის ორი ძირითადი მიზეზი არსებობს - საყოველთაო დაზღვევის და საპენსიო ფონდის ხარჯების ზრდა.

პირველ რიგში განვიხილავ, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის იმ ძირითად ფაქტორებს, რომლებიც შესაძლებელია განაპირობებდეს არაგეგმიურ ხარჯებს:

ჯანდაცვაზე ხარჯების ზრდა - მსოფლიოში უკვე არსებული ტენდენციის მიხედვით, ჯანდაცვის ხარჯები მაღალი ტემპით იზრდება, რაც თავის მხრივ, განპირობებულია სექტორში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვით და ახალი მედიკამენტების შექმნით, ფასების ინფლაციით და სხვ.

უფასო მომსახურების ეფექტი - საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებამ საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება მისცა უფასოდ ესარგებლათ იმგვარი სამედიცინო მომსახურებით, რომლის მიღებაც მოსახლეობის უმრავლესობას საკუთარი სახსრებით არ შეეძლო ან თავს იკავებდა. შესაბამისად, პროგრამის ამოქმედებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა ექიმებთან მიმართვიანობის რაოდენობა. მაგალითად, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2014 წელს ექიმთან მიმართების რიცხვი 2011 წელთან შედარებით 54%-ით გაიზარდა. დროთა განმავლობაში პროგრამის სიკეთეებზე მოსახლეობის მეტი ინფორმირებულობა, სავარაუდოდ გამოიწვევს ექიმთან მიმართვიანობის რიცხვის კიდევ უფრო მომატებას, რაც თავის მხრივ, გაზრდის პროგრამის ხარჯებს.

პროგრამის ეფექტური მართვა - პროგრამის ხარჯების ზრდის შეკავება მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ პროგრამის ეფექტურ მართვაზე. პროგრამის მასშტაბები წარმოშობს სააგენტოს მიერ სამედიცინო დაწესებულებების სრულფასოვანი კონტროლის შეუძლებლობის რისკებს. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედების შემდეგ გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციების მკვეთრი მატება (CURATIO INTERNATIONAL FOUNDATION -ის 2015 წლის კვლევის მიხედვით, გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციების შემთხვევების მატება 314%-ს შეადგენს) ბუნებრივად ბადებს კითხვებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად ეფექტურად უმკლავდება სააგენტო სამედიცინო დაწესებულებების მიერ, დამატებითი ანაზღაურების მიღების მიზნით, პაციენტის დიაგნოზის ხელოვნურად დამძიმების ან შეცვლის შემთხვევების მონიტორინგს.

დაზუსტებული ინფორმაციის არ არსებობა - პროგრამის ეფექტურ მართვას მნიშვნელოვნად ართულებს, აგრეთვე, კერძო სადაზღვევო კომპანიებში დაზღვეული მოქალაქეების შესახებ დაზუსტებუ-

ლი ინფორმაციის არ არსებობა. პროგრამის ამოქმედების შემდგომ კერძო სადაზღვევო კომპანიებმა პერსონალური მონაცემების დაცვის მოტივით სოციალური მომსახურების სააგენტოს აღარ მიაწოდეს მათთან დაზღვეული მოქალაქეების შესახებ ინფორმაცია. შესაბამისად, დღეის მდგომარეობითაც, პროგრამის ბენეფიციარის განსაზღვრის ათვლის წერტილად კვლავ მიჩნეულია 2013 წლის 1 ივლისი. აქედან გამომდინარე, ის მოქალაქეები, რომლებსაც 2013 წლის პირველი ივლისის შემდგომ შეუწყდათ კერძო დაზღვევა, სარგებლობენ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მინიმალური პაკეტით, ხოლო, ის მოქალაქეები რომლებიც 2013 წლის პირველი ივლისის შემდგომ ჩაერთვნენ კერძო დაზღვევაში, არ ეთიშებიან სახელმწიფო პროგრამას და სარგებლობენ ე.წ. ორმაგი დაზღვევით. ორმაგი დაზღვევა გულისხმობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და კერძო სადაზღვევო კომპანიების მომსახურებით ერთდროულად სარგებლობას, როცა კერძო სადაზღვევო კომპანიები ახორციელებენ მხოლოდ იმ მომსახურების ანაზღაურებას, რომელსაც არ ითვალისწინებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა. აღნიშნული გარემოება მნიშვნელოვნად ზრდის პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობას და ხარჯებს.

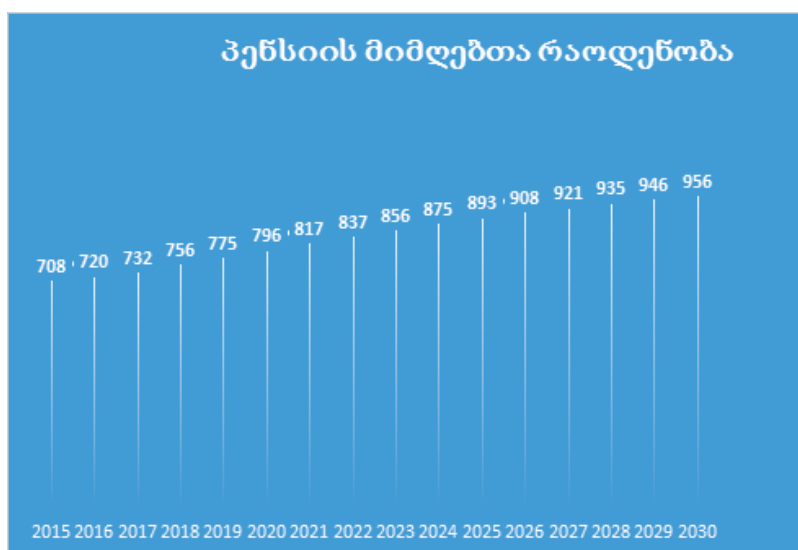
მეორე საკითხი რასაც განვიხილავ, არის საპენსიო დანახარჯების მუდმივი ზრდის გამომწვევი ძირითადი ფაქტორები:

პენსიის რაოდენობრივი ზრდა - 2004 წლიდან 2016 წლამდე პენსიის მკვეთრი ზრდის ფონზე სოციალური პენსია საარსებო მინიმუმს მიუახლოვდა. 2015 წელს საპენსიო ხარჯებმა მშპ-ს 4.25 % შეადგინა, მაშინ როდესაც 2006 წელს, ის 1.05% იყო. 2014 წელს ყოველთვიური სოციალური პენსია შეადგენდა 150 ლარს და ოდნავ ჩამოუვარდებოდა საარსებო მინიმუმს, რომელიც იმ დროისთვის 159.4 ლარი იყო. აღსანიშ-

ნავია, რომ 2006 წელს სოციალური პენსია საარსებო მინიმუმის 50%-ზე ნაკლებს წარმოადგენდა. ამგვარად, 2006-დან 2013 წლამდე, სოციალური პენსია საარსებო მინიმუმს მიუახლოვდა. არსებულ საპენსიო სისტემას არ გააჩნია სამართლებრივი და განერილი კრიტერიუმები, რომელიც განსაზღვრავს, თუ რა შემთხვევაში და რა ოდენობით გაიზრდება სოციალური პენსია. ეს თავის მხრივ განაპირობებს არასტაბილურ გარემოს ბიუჯეტის გაგეგმვისას. თუ პენსია არ გაიზრდება რეგულარულად, არსებობს პენსიის რეალური ღირებულებისა და მსყიდველუნარიანობის შემცირების საფრთხე, განსაკუთრებით მაღალი ინფლაციის შემთხვევაში.

ასაკით პენსიონერთა რაოდენობის ზრდა - პენსიონერთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში. ზრდის ტენდენცია მაღალი ალბათობით შენარჩუნდება. დემოგრაფიულ ანალიზზე დაყრდნობით ნავარაუდებია, რომ მომავალი 15 წლის მანძილზე პენსიონერთა რაოდენობა 30%-ით გაიზრდება და 2030 წლისათვის 950 ათასს მიაღწევს (იხ. დიაგრამა 1), რაც ნიშნავს, რომ ასაკოვანი მოსახლეობის რაოდენობა მთლიანი მოსახლეობის ერთი მეოთხედი იქნება. აღნიშნული მატება, დროის მცირე მონაკვეთში, მნიშვნელოვან დემოგრაფიულ ცვლილებას წარმოადგენს. საქართველოს მოსახლეობა საგრძნობლად შემცირდა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში.

დემოგრაფიული მდგომარეობა - საქართველოს დემოგრაფიული შემადგენლობა მნიშვნელოვნად შეიცვალა ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში. ასაკოვანი მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა და შობადობის დონის შემცირება თვალსაჩინო ტენდენციაა, რამაც, თავის მხრივ, შრომისუნარიანი მოსახლეობის რაოდენობის შემცირება გამოიწვია. ასევე, მნიშვნელოვანი გავლენა სამუშაო ძალის შემცირე-



დიაგრამა 1: ასაკით სოციალური პენსიის მიმღებთა რაოდენობრივი ზრდის დინამიკა (2015-2060)
წყარო: საქართველოს კანონის პროექტი - დაგროვებითი პენსიის შესახებ, გვ 15.

ბაზე იქონია მზარდმა მიგრაციამ და სამუშაო ადგილების შემცირებამ. ამავ პერიოდში, სიცოცხლის ხანგრძლივობა საპენსიო ასაკის მიღწევითანავე გაიზარდა. შედეგად, შემცირებული რაოდენობის სამუშაო ძალის მოსახლეობას უწევს მზარდ საპენსიო ასაკში მყოფი მოსახლეობის არაპირდაპირი ფორმით დაფინანსება. ამავდროულად, მთავრობის საბიუჯეტო ვალდებულებები, სოციალური პენსიის კუთხით, ყოველწლიურად იზრდება, რაც კლებადი სამუშაო ძალის და მზარდი პენსიონერთა რაოდენობის ფონზე სირთულეს წარმოადგენს. ამრიგად, გრძელვადიან პერსპექტივაში არსებული ჩანაცვლების კოეფიციენტის შენარჩუნება გართულებულია, რომ აღარაფერი ვთქვათ, ჩანაცვლების კოეფიციენტის გაზრდაზე.

დასკვნა

როგორც შესავალში აღვნიშნე, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის წინაშე არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით, საქართველოს მთავრობის დღის წესრიგში დადგა პროგრამის გარკვეული ფორმით შეცვლის აუცილებლობა.

დადებითად ვაფასებ იმ მოსაზრებას, რომ საყოველთაო პაკეტების ცვლილების შემდეგ, თითოეული მოქალაქე დაფინანსებას ქონებრივი მდგომარეობისა და შემოსავლების მიხედვით მიიღებს. შესაბამისად, საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით ვეღარ ისარგებლებენ კერძო კომპანიებში დაზღვეული მოქალაქეები, ასევე შედარებით მაღალი შემოსავლების მქონე ოჯახები, ღარიბებისთვის კი კიდევ უფრო გაფართოვდება ის პაკეტი, რომელსაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ამ დროისათვის მოიცავს, მათ შორის, მედიკამენტების ხარჯზე.

თუმცა აუცილებელია მკაცრად განისაზღვროს, სად გაივლება ეგრეთ წოდებული ქონებრივი ზღვარი, მიიღებს თუ არა დაფინანსებაში მონაწილეობას დამსაქმებელი.

პროგრამის ეფექტურობას მნიშვნელოვნად გაზრდის შემდეგი საკითხების გათვალისწინება:

თუკი შემუშავდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის სტრატეგია და გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმა. პროგრამის განვითარების გრძელვადიანი ხედვა მეტ სტაბილურობას მიანიჭებს, როგორც პროგრამას, ასევე კერძო სადაზღვევო სექტორს.

დაიხვეწოს პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი სახელმწიფო სახსრების განკარგვის მონიტორინგის სისტემა, რომ მაქსიმალურად შემცირდეს სამედიცინო დაწესებულებების არაკეთილსინდისიერი საქმიანობის ალბათობა.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონში შევიდეს შესაბამისი ცვლილება, რომელიც, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ინტერესებიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს მისცემს კერძო სადაზღვევო კომპანიებში დაზღვეულ პირთა იდენტიფიცირების საშუალებას.

რაც შეეხება საპენსიო დანახარჯებს, არსებული

საპენსიო სისტემა ფინანსდება ერთიანი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. არსებული სისტემის ანალიზმა კი გვიჩვენა, რომ მხოლოდ სახელმწიფო დაფინანსების ხარჯზე საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში შეუძლებელია არსებული ჩანაცვლების კოეფიციენტის შენარჩუნება. სწორედ ამიტომ, საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა „საქართველოს საპენსიო რეფორმა“. საპენსიო რეფორმის ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ადმინისტრირება კრიტიკის საგანია იმ არგუმენტით, რომ ეკონომიკის სამინისტროს მიერ საპენსიო რეფორმის განხორციელებამ შესაძლოა კაპიტალის ბაზრის განვითარებისა და საპენსიო რეფორმის ფუნდამენტური მიზნები ინტერესთა კონფლიქტში მოაქციოს. თუნდაც იმიტომ, რომ საპენსიო ფონდები ყოველთვის მნიშვნელოვან პოზიტიურ გავლენას ახდენენ კაპიტალის ბაზრის განვითარებაზე — ამაზე ემპირიულ სამეცნიერო კვლევებში არსებობს აღიარებული მყარი კონსენსუსი.

ვინაიდან სახელმწიფო საპენსიო ფონდების მართვის დელეგირებას კერძო სექტორზე ახდენს, კორპორაციული მართვის სტანდარტებს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, განსაკუთრებით განვითარებადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში, რადგან საპენსიო რეფორმის შემდეგ საპენსიო ფონდები უმსხვილესი ინსტიტუციონალური ინვესტორები ხდებიან. საპენსიო ფონდების ადმინისტრირებას ასევე უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება იმისათვის, რომ დანაზოგების ინვესტირება და კონცენტრაცია არ მოხდეს ეკონომიკის მხოლოდ ერთეულ სექტორებში.

მივსალმები კერძო დაგროვებითი სისტემების ჩამოყალიბებას და განვითარებას, მაგრამ არ ვეთანხმები იმ გარემოებას, რომ ის სახელმწიფოს და პარლამენტის დაქვემდებარებაში იყოს. აუცილებელია კერძო სექტორის მხრიდან აქტიური ჩართულობა და მათ მიერ ამ ბაზრის ჩამოყალიბება და გაძლიერება. რაც თავის მხრივ, გააძლიერებს ფინანსურ ბაზრებს, გააუმჯობესებს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას და რაც მნიშვნელოვანია უზრუნველყოფს პენსიის ღირსეულ ზრდას.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. მ. ვანიშვილი, ნ.ჭიკაიძე, ნ. ვანიშვილი. სოციალური ეკონომიკა. 2017 წ.
2. ჭიკაიძე ნ. შრომის ბაზრის აქტუალური პრობლემები საქართველოში; ჟურნ. „სეუ და მეცნიერება“. თბ. 2017წ., 6(6).
3. ჭიკაიძე ნ. დაგროვებითი პენსიის სოციალურ-ეკონომიკური პერსპექტივები. ჟურნ.ეკონომიკა, თბ. 2017, N3-4.
3. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3839800>
5. <http://geostat.ge/>
6. <http://mof.ge/>
7. <https://idfi.ge/ge/challenges-of-universal-healthcare-program-and-ways-to-overcome-them>